

【二羊经方实践录】反复胃胀胃痛5年余加重半年

二羊 养阳医斋 2022年10月26日 18:33 广东

案例一：反复胃胀胃痛5年加重半年

徐某，男，54岁

首诊，2022.1.19 经科室同事介绍来诊。五年来反复胃脘胀痛，吃饱后容易加重，时有暖气烧心。以往看西医为主，服用药物泮托拉唑/奥美拉唑。2021.12.13日胃镜检查：慢性萎缩性胃炎伴糜烂，腺体轻、中度肠化。既往痔疮，排便疼痛，偶有出血。容易便秘。睡眠入睡困难。口干明显无口苦

舌红苔黄腻，脉寸短关浮紧。

序号	病理号	补充	冰冻	分子	姓名	门诊号	住院号	接收日期	取材医生
1	2123947	补充	冰冻	-	徐		-	2021-12-13	吕敏静

第1/1页, 共1条记录 1

临床诊断：慢性萎缩性胃炎

肉眼所见：1. (胃体) 灰白黏膜1粒，0.3x0.2x0.2cm，全埋。
2. (胃角) 灰白黏膜2粒，0.3x0.2x0.2cm，全埋。
3. (胃窦) 灰白黏膜2粒，0.3x0.2x0.2cm，全埋。

镜下所见：

病理诊断：1. (胃体) 黏膜糜烂，边缘隐窝上皮肠化、轻度不典型增生；
2. (胃角) 黏膜慢性萎缩性胃炎伴糜烂，腺体中度肠化；
3. (胃窦) 黏膜慢性活动性炎伴糜烂，灶性腺体肠化合并轻度不典型增生。
注：建议治疗后再检，进一步排除低级别上皮内瘤变。

免疫组化：

养阳医斋

这是典型的慢性胃炎，并且是萎缩性的慢性胃炎，萎缩性胃炎主要表现为胃慢慢失去胃的消化功能，慢慢变成肠一样的。

西医治疗治疗大多都是对症治疗，胃黏膜保护药，抑制胃酸的药。吃了胃就缓解一点，不吃就不行。最主要的是长期吃这些药并不会让这个胃病发展停下来。继续发展就是胃癌。

萎缩性胃炎比非萎缩的难治，且都是需要长期吃药。很多人因为胃的不舒服，搞到整个人焦虑不安。所以很多还伴随失眠等。所以很多人引用黄帝内经的话“胃不和则卧不安”，从这点来治疗失眠。

这个案例还是非常典型，典型在症状，加慢性萎缩性胃炎的西医诊断。

不管怎么样，中医还是辨证论治。

目前主要症状表现：胃痛胀痛，食后容易饱胀，伴暖气烧心。痔疮大便容易干结，口干明显。睡眠差

伤寒杂病论：关脉浮，其人心下痞

心下痞，也就是心窝处总有饱胀感，这个人体质偏湿热可以用半夏泻心汤打底。加了三味其药三剑客“木香/佛手/砂仁。

详细信息列表:

方序	数量	用法	制方	费标	开处方	科室	开处方医生	开处方时间
01	7服	温服	天一	收	复医学科	M	杨燁	2022年01月19日 15时11分00秒

No.	药品名称	用量	单位	特殊用法	单价	公费
01	法半夏	15.00	g	无	¥0.325	公费
02	干姜	10.00	g	无	¥0.0725	公费
03	黄连	3.00	g	无	¥0.2588	公费
04	黄芩	10.00	g	无	¥0.0713	公费
05	红参须	10.00	g	无	¥0.9125	公费
06	麸炒枳实	10.00	g	无	¥0.085	公费
07	大枣	15.00	g	无	¥0.0438	公费
08	制佛手	10.00	g	无	¥0.16	公费
09	砂仁(后下)	1.00	包	无	¥4.50	公费
10	木香(后下)	1.00	包	无	¥0.2625	公费

 养阳医斋

吃一周后

2.26日复诊

服用上方后胃脘不适症状好转，胃痛胃胀基本消失，但吃了辛辣后大便干结，痔疮有点犯病。

上方基础上加麦冬/槐花/地榆。

三诊3.17

服用上方后大便稍改善，如没有吃特别刺激食物，胃脘无不适。

近两日吃了水果，胃脘有些胀满，大便稀烂粘腻。

前方去麦冬，加藿香/白术/ 芳香化湿加健脾燥湿同用。

四诊4.8

胃脘情况基本稳定，偶有胃腹胀满，大便容易干结，前方去香燥藿香白术，去红参换党参，加大腹皮

No.	药品名称	用量	单位	特殊
01	黄连	3.00	g	无
02	黄芩	10.00	g	无
03	熟党参	10.00	g	无
04	麸炒枳实	10.00	g	无
05	大枣	15.00	g	无
06	制佛手	10.00	g	无
07	砂仁(后下)	2.00	包	无
08	火麻仁	15.00	g	无
09	地榆	15.00	g	无
10	槐花	15.00	g	无
11	麦冬	15.00	g	无
12	麸炒白术	15.00	g	无
13	法半夏	15.00	g	无
14	干姜	10.00	g	无
15	大腹皮	15.00	g	无

养阳医斋

五诊，5.17胃部无不适，大便时有便秘，时有干结或粘腻难解。前方加白术

六诊6.02 症状稳定，只是饮食过饱或者吃了甜食胃腹部容易不适，吃了油炸食物，大便时有血丝。前方加蒲公英/生地

前方

七诊6.21 症状大致同前，继续服用前方。

八诊，9.28胃肠功能恢复，胀痛症状基本消失，饮食正常。仍有偶有失眠差，入睡困难，口干明显，无口苦，大便偏干结。脉沉数，左脉细数无力。

考虑患者长期用药偏燥，黄连黄芩苦燥，加上半夏白术干姜等药服用，祛湿后阴不足明显。

用药去掉干姜，加麦冬生地知母/女贞子/墨旱莲/龟板养阴。

小结：

病人9月内来看病八次，每次服用中药1周。

经调理胃部症状基本消失，目前主要有阴不足之症。

方序	数量	用法	制方	费标	处方科	开处方医生输入	开处方时间
01	7服	温服	一天一	己收费	复医学科	杨烱	2022年09月28日 08时16分38秒
No.	药品名称	用量	单位	特殊用法	单价	公费	
01	地黄（生地黄）	15.00	g	无	¥0.1188	公费	
02	麸炒枳实	10.00	g	无	¥0.0825	公费	
03	大枣	15.00	g	无	¥0.0438	公费	
04	火麻仁	15.00	g	无	¥0.0488	公费	
05	地榆	15.00	g	无	¥0.0688	公费	
06	槐花	15.00	g	无	¥0.1613	公费	
07	麦冬	15.00	g	无	¥0.185	公费	
08	姜竹茹	15.00	g	无	¥0.0425	公费	
09	法半夏	15.00	g	无	¥0.325	公费	
10	黄连	3.00	g	无	¥0.40	公费	
11	石菖蒲	10.00	g	无	¥0.1813	公费	
12	盐知母	15.00	g	无	¥0.0813	公费	
13	女贞子	15.00	g	无	¥0.0363	公费	
14	墨旱莲	15.00	g	无	¥0.065	公费	
15	醋龟甲（先煎）	15.00	g	无	¥0.325	公费	

养阳医斋

前期治疗为治标为主，湿热气滞等标实症状消退后，后续需要养阴益气固本。

徐文兵讲课说慢性萎缩性胃炎不能用经方，不能用温热药。在特定的证型是不适合的，例如气阴两虚的状态，过热过燥药物都不适合。

但我们也不能看到慢性胃炎就等同不能用温热药，还是看具体病证。本例患者前期以湿热为主，会用到偏燥的药，无论是清热的苦燥还是健脾祛湿的温燥药。复杂情况同时用，当湿不再了，表现出来阴不足，自然调整思路。

我自己的体会还是仲景先师总结的，随证治之。

不能一叶障目不见泰山，也不能刻舟求剑，用西医诊断把自己固定死。

最后：本案例仅作个案思路分享，不能套用本方，每个人体质和情况不一样。分享的医案，看病思路和用药完全区别于二羊当时看了病人后的判断，不接受反驳，因为你没见过这个病人。

当然也欢迎大家多分享自己的案例或者病友的治疗经历。

下次分享另外一种情况的慢性胃病。

预告：

吴某，男，慢性胃病加重，不能进食，胃脘胀痛，纳差食少，3月内消瘦10多斤，怀疑是不是胃癌？了解更多参考：养阳医斋

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

iPhone 用户赞赏专用



中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色梔子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。

胃病 · 目录

下一篇 · 【二羊经方实践录】胃病吃不下饭，暴瘦10余斤，我担心胃气败了 >

